

FRACTURAS NASALES

Luz López Flórez, Cesáreo López Rodríguez, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Los traumatismos nasales constituyen un alto porcentaje de las urgencias, siendo las fracturas nasales las más frecuentes entre todas las fracturas de la cara y representando el 30-40 % de todas las fracturas óseas, lo que nos obliga a tener un conocimiento preciso del diagnóstico, manejo y complicaciones de las mismas.

Predominan en varones jóvenes salvo en la tercera edad donde existe una incidencia parecida. Las causas más frecuentes son las agresiones, los accidentes de tráfico y deportivos así como los traumatismos accidentales como caídas y golpes.

La proyección de la nariz sobre el plano coronal del resto de la cara hace que sea una estructura especialmente susceptible a recibir traumatismos aislados en el adulto, mientras que en la edad pediátrica la estructura más proyectada es la frente confiriendo cierta protección a la nariz.

Clasificación

En la literatura existen múltiples sistemas de clasificación de fracturas nasales. Una de las más conocidas es la clasificación de Rohrich (Tabla 1), aunque en la práctica clínica no se suele usar ningún sistema de clasificación ya que el manejo y tratamiento urgente no varía entre las fracturas más simples y las fracturas más complejas suelen conllevar lesiones más extensas que sobrepasan los límites de la nariz y minimizan su importancia.

Clasificación de Rohrich y Adams

I	Fractura simple unilateral.
II	Fractura simple bilateral.
III	Fractura conminuta. a) Unilateral b) Bilateral c) Frontal
IV	Fractura compleja (huesos nasales y septo). a) Hematoma septal asociado. b) Laceraciones nasales.
V	Fracturas naso-orbito-etmoidales.

Tabla 1

Anamnesis

Debe incluir:

- Edad. Anticoagulación. Antiagregación. Riesgo hemorrágico.
- Mecanismo y fuerza de la lesión.
- Pérdida de consciencia:
 - Si positiva: protocolo de traumatismo craneoencefálico (valorar TAC craneal).
- Síntomas acompañantes.
- Insuficiencia respiratoria nasal.
- Deformidades nasales previas.
- Pedir fotos (DNI, carnet de conducir) para comparar.

Exploración física básica

- Inspección:** cutánea (heridas, laceraciones, abrasiones), laterorrinia, edema, equimosis o hematomas infraorbitarios.

- **Palpación:** crepitación de huesos, hundimientos o escalones óseos.
Ha de ser sistemática: desde la inserción de los huesos propios al frontal bajando por su inserción al maxilar y volver a subir por la línea media (para mejorar la palpación humedecer las yemas de los dedos).
 - No olvidar zonas adyacentes: contorno de fosas nasales, arcos ciliares, malares y cigomáticos.
- **Rinoscopia anterior:** lesión de mucosas, desviación septal y hematoma septal.

Pruebas complementarias

- **Radiografía de huesos propios:** se desaconseja la práctica sistemática debido a su valor limitado. Solo para dejar constancia gráfica en caso de agresión o accidente.
- **TAC craneofacial:** en traumatismos severos con sospecha de afectación de otros huesos.

TRATAMIENTO

a. Menos de 4-5 horas tras traumatismo (no existe aún edema que dificulte la exploración): reducción cerrada inmediata.

- Infiltración con anestesia local (por ejemplo, Lidocaína 1% + Adrenalina) en nervios infraorbitarios. Un método práctico es administrar el anestésico por debajo del labio superior para alcanzar la fosa canina, así se pretende evitar los pinchazos innecesarios en el tejido cutáneo de la cara. Algunos autores recomiendan anestesiarse también la región de la raíz nasal con el fin de bloquear los nervios infratrocleares.
- Lentinas con vasoconstrictor y anestésico tópico en ambas fosas nasales.
- Instrumentos diseñados: fórceps de Asch y Walsham, elevador de Boies, etc o simplemente emplear el mango de un bisturí o una pinza Kocher. Medir externamente la longitud del instrumento necesaria para alcanzar el hueso propio hundido para no lesionar otras estructuras, introducirlo en la fosa nasal del lado hundido y realizar un movimiento conjunto de elevación de hueso propio hundido con medialización del hueso contralateral.
- Tras reducción: férula nasal durante 1 semana.

b. Más de 4-5 horas tras traumatismo (existe importante edema que puede enmascarar fracturas): revaloración en 48-72 horas con reducción cerrada de forma diferida si procede (no se compromete el resultado hasta 2 semanas tras el traumatismo).

c. Fracturas con afectación septal y fractura conminuta: fijación interna con gasa de borde o tapones tipo Merocel® en cada fosa nasal para obtener un efecto de soporte mecánico evitando sinequias y retirada en 3 días.

d. Reducción abierta: en quirófano bajo anestesia general.

e. En todos los casos:

- Limpieza cutánea y sutura de las lesiones si procede.
- Limpieza endonasal con aspirado de coágulos en caso de presencia.
- Frío local intermitente durante las primeras 48 horas.
- Antiinflamatorios y analgésicos.
- Revisión a los 6 meses: valorar septo/rinoplastia.

Complicaciones

a. Epistaxis

- Autolimitada: lavados nasales con suero fisiológico varias veces al día durante 1 semana.
- Leve persistente o recurrente: sustancias hemostáticas como Espongostan® o Surgicel®.
- Casos incoercibles: taponamiento completo de la fosa con Merocel® y retirada en 3 días.

b. Hematoma septal: drenaje, taponamiento nasal, cobertura antibiótica y reevaluación en 48 horas con nuevo drenaje si persiste.

Atención

- Ante cualquier traumatismo nasal:
 - Descartar hematoma septal.
 - Si pérdida de consciencia: necesidad de protocolo TCE y valorar TAC craneal.

BIBLIOGRAFÍA

- Chegar BE, Tatum SA. Nasal fractures. In: Flint PW, Haughey BH, Lund V, et al, eds. Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015:chap 33.
- Rohrich RJ, Adams WP Jr. Nasal fracture management: minimizing secondary nasal deformities. Plast Reconstr Surg. 2000 Aug;106(2):266-73. Review.
- Perkins SW, Dayan SH. Management of nasal trauma. Aesthetic Plast Surg. 2002 Nov;26 Suppl 1:S3.
- Malaty J. Facial and skull fractures. In: Eiff MP, Hatch R, eds. Fracture Management for Primary Care, Updated Edition. 3rd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2018:chap 17.